

SECTRA RIS/PACS i OUS

Hurtig-guider

RAM-prosjekt 2022

Versjon	Dato	Endring	Endret av:
1	06.10.2022	Dokument opprettet	Bente Flaen
2	19.10.2022	Endret	Bente Flaen

Ansvarlig:

Bente Flaen

Medforfattere:

Funksjonell undergruppe radiografer/bioingeniører RAM

Superbrukere RAM

MANUELL REGISTRERING AV HENVISING

Stå i RIS-vinduet og åpne «Henvisningsvinduet» (F3)	
Trykk på «Ny», eller Ctrl + N.	
Fyll inn fødselsnummer, trykk søk. Hadde du markert en pasient i PACS vil fødselsnummer være utfyllt. Trykk «Ja» på varsel om at «verdi ikke kan tolkes som fødselsnummer».	Fødselsnummer 123456789321
Trykk på « Henvisende instans »: Skriv inn hele eller deler av avdelingens forkortelse. Trykk [Tab] på tastaturet, eller klikk på kikkerten med musen. Har du ikke forkortelsen? Skriv stjerne og deler av avdelingsnavnet.	Henvisende instans akm Henvisende instans *nevro
Vindu for « Henvisende lege » kommer automatisk: Skriv inn etternavn eller HPR-nummer og trykk [Tab] på tastaturet.	Henvisende lege Olsen, John
Vindu for valg av « Undersøkelse » kommer automatisk: I feltet «Undersøkelsesnavn i RIS» skriver du modalitet og undersøkelse. Dobbeltklikk på ønsket undersøkelse. Du kan legge til flere. Dobbeltklikk for å fjerne. Velg bestillingsgruppe for f.eks Traume, Trombolyse, NUK us eller RGA/RGV undersøkelser	Undersøkelsesnavn i RIS CT BEK Bestillingsgruppe Undersøkelsesnavn i RIS CT Bekken CT Bekken - Ablasjon (int.) CT Bekken - Bløtdelsbiopsi (int.) CT Bekken - Drenasje (int.)
Fagområder: Har du lagt til flere undersøkelser kan de få hvert sitt fagområde.	Fagområder
Velg hastegrad: Har du lagt til flere undersøkelser kan de få hver sin hastegrad.	Velg hastegrad
Henvisningskategori: Velg «Inneliggende, ikke time til DIPS» ved øhjelp, ev velg aktuell kategori (gjelder nuk).	Henvisningskategori ende, ikke time til DIPS
Skal radiolog prioritere og protokollere henvisningen? Kontroller at «Prioritere» er huket av.	☒ Prioritere
<i>Om henvisning skal skannes trenger man ikke fylle inn feltene «Problemstilling» eller «Kliniske opplysninger».</i>	
Akutt: Dersom us er akutt innen 30min, hake på akutthaken. Du kan booke direkte på lab fra RIS etter at du har klikket lagre.	
Lagre henvisningen: Trykk på «Lagre»-ikonet.	
Du er ferdig i RIS, gå til PACS. Henvisningen du laget vil være valgt. Skann henvisningen henvisningsvinduet, om dette er aktuelt.	
Du kan sette undersøkelsen(e) direkte på lab i Undersøkelsesvinduet (F10).	

VERIFISERING AV HENVISNING I PACS

INFORMASJONSVINDUET (F9)

Finn henvisning på verifiseringsliste, ev søk opp pasienten. Henvisning har status «registrert».

Registrert

Sjekk at riktig klinikk er registrert, ev endre klinikk.

Legg inn fagområde.

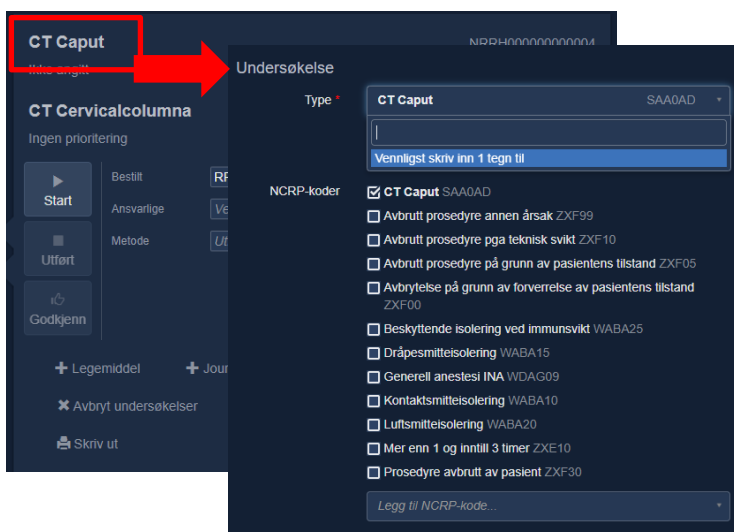


UNDERSØKELSESVINDUET (F10)

Klikk på undersøkelsesnavnet og endre til riktig undersøkelsesnavn etter hva som står på henvisning.

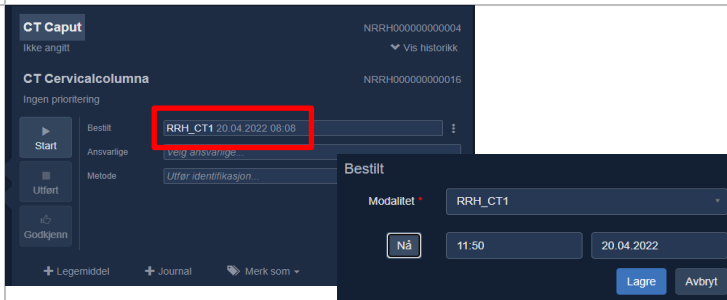
Søk etter korrekt undersøkelsesnavn, f.eks endre fra «02 CT OUS» til «CT Thorax»

Klikk lagre.

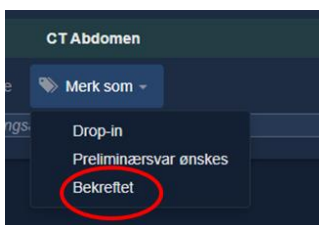


Legg på aktuell lab.

Evn endre dato og tid.



Klikk på «Merk som» til venstre og klikk på «Bekreftet».



DOKUMENTERING AV UNDERSØKELSE

UNDERSØKELSESVINDU (F10)

Klinikk og fagområde:

Kontroller at klinikk og fagområde er korrekt.
For å endre, gå i Informasjonsvinduet (F9) og klikk på fagområdet eller klinikken.

RUL_Radiologi Ullevål OUS | 
RUL Abdomen
RUL_Radiologi Ullevål

Undersøkelse:

Legg til/endre/fjern undersøkelser etter hva som er utført.

Alltid kontrollere NCRP-koder:

Legg til tilleggskoder ved f.eks smitte, avbrutt, sidebet., spektroskopi, perfusjon, lange us., anestesi m.m.

Klikk på undersøkelsesnavnet øverst i vinduet. Huk av på relevante forslag, eller søk opp i feltet «Legg til NCRP-kode...»

Regel: Kun 1 hovedkode pr undersøkelsesnavn (linje), men kan ha flere tilleggskoder.

Ved intervensjoner, legg all dokumentasjon på diagnostisk linje.

Ansvarlige (O):

Legg inn alle radiografer og radiologer involvert på lab.

Ansvarlige

Identifisering av pasient (D):

Velg et alternativ. Signer selv eller endre signerende bruker.

Metode

Legemiddel/kontrast/radiofarmaka (P):

Ved flere undersøkelseslinjer, velg en us å registrere på. Intervensjoner registrerer på diagnostisk undersøkelse.

Fyll inn alle felt med rød stjerne.

Legg inn flow i kommentarfeltet.

Signer selv eller endre signerende bruker.

+ Legemiddel

Kommentar til undersøkelse (J):

Klikk på «Journal», velg relevant anmerkning og fyll ut om aktuelt.

Signer selv eller endre signerende bruker.

+ Journal

Viktig pasientinfo:

Dersom du skal legge til viktig pasientinfo, klikk på feltet «Ingen viktig pasientinfo». Skriv dato, brukernavn og ev lokasjon det gjelder.

Velg også OBS! eller annet fra meny «Legg til særlig kommentar».

Denne infoen følger pasienten i PACS og RIS og vises med rød tekst.

Viktig pasientinfo. /041022
brukernavn

INFORMASJONSVINDU (F9)

Legg til demo (Shift+D):

Ved bruk av ikonet på verktøymenyen legges kun 1 us til demo.

 Til demo

Ved flere undersøkelser: Legg til demo via informasjonsvinduet (F9)

Marker aktuell(e) undersøkelse(r), høyreklikk eller hurtigtast «SHIFT+D» og legg til demo. Velg aktuell demo fra liste.

Demonstrasjon

 Legg til demonstrasjon...

Skanne dokumenter (Alt+S):

Klikk på skannesymbolet for å skanne eller hurtigtast.



Granskende lege (ved UL og intervensjoner):

Høyreklikk på undersøkelsen i Informasjonsvinduet (F9) og velg «Granskende lege» Velg «Angi granskende lege» (Alt+Y) og velg lege fra aktuell hovedrolle.

Angi granskende lege...

FLYTTE UNDERSØKELSE (INNELIGGENDE/Ø-HJELP)

... TIL ANNEN LAB

I Undersøkelsesvinduet (F10) trykker du på lab-navnet til høyre for «Bestilt».

Bestilt RUL_CT2 09.09

Velg den nye laben i listen «Modalitet» og klikk lagre.

Modalitet RUL_CT2

... TIL ANNEN DAG

I Undersøkelsesvinduet (F10) skriv henvisningsanmerking hvorfor us er flyttet til annen dag. Signer selv eller velg annen bruker som skal signere.

Trykk på lab-navnet til høyre for «Bestilt» og endre dato/tid.

Bestilt RUL_CT2 09.09

Klokkeslett: Man *kan* velge klokkeslett i fortiden.

Dato: Må være i dag eller fremover i tid.

Nå 08:59 14.09.2022

OBS: Dersom man skal flytte timen til en tidsslått som kontor/timebestillingen booker på så må man endre timen i Timebok i RIS ellers risikeres dobbeltbooking. Gjelder ikke øhjelp tidsslåtter.

... TIL ANNEN KLINIKK

I Informasjonsvinduet (F9) – øverst til høyre – trykker du på klinikken.

Velg klinikken du ønsker å flytte til.

Alle undersøkelser på henvisningen får samme klinikk.

MO_RUL_Radiologi Ullevål OUS ⓘ
RUL Abdomen
Ingen seksjon

Velg fagområde tilhørende den andre klinikken om us skal beskrives på en annen klinikk.

MO_RUL_Radiologi Ullevål OUS ⓘ
RUL Abdomen
Ingen seksjon

Gå i Undersøkelsesvinduet (F10) og klikk på feltet for «Bestilt» for å velge aktuell lab som undersøkelsen skal flyttes til. Endre evt dato og tid.

Bestilt NRH_PTCT1 02.09.2022 07:52

Om undersøkelsen skal utføres på tvers av lokasjoner, eksempelvis utføres på Aker men beskrives på Ullevål, se egen prosedyre i Brukermanualen.

... TIL ANNET FAGOMRÅDE

I Informasjonsvinduet (F9) – øverst til høyre - trykker du på fagområdet

Velg nytt fagområde.

Om det er flere undersøkelser på henvisningen må du endre fagområde for hver enkelt undersøkelse.

2/2 ⏪ ⋮ ⏩
MO_RUL_Radiologi Ullevål OUS ⓘ
RUL Abdomen
Ingen seksjon

INNELIGGENDE/Ø-HJELP SKAL GJØRES POLIKLINISK

PASIENTEN ER SKREVET UT, MEN US SKAL GJØRES POLIKLINISK

Legg til Henvisningsanmerkning som forklarer hvorfor. Eksempel:
«Pasienten er skrevet ut. Us. skal gjøres poliklinisk» Signer selv eller
endre bruker om man vil signere med annen bruker.

Legg til henvisningsanmerkning...

Legg til flagg «**Time må endres**».

*Henvisningen forsvinner fra lab-listen, men dukker nå opp
på en liste hos kontoret.*

Time kort varsel

N

Time må endres

Talk borte

US BLE AVBRUTT OG PASIENTEN SKAL SETTES PÅ NY TIME

I Undersøkelsesvindu (F10):

Klikk på undersøkelsesnavnet som står rett over «Start»-knappen.

Legg til NCRP-avbrutt kode, f.eks «Prosedyre avbrutt av pasient».

RG Thorax



Start

Bestilt

Ansvarlige

RG Thorax

☐ Skal prioriteres

☒ RG Toraks SSC0AA

☐ Avbrutt prosedyre annen årsak ZXF99

☐ Avbrutt prosedyre pga teknisk svikt ZXF10

☐ Avbrutt prosedyre på grunn av pasientens tilstand ZXF05

☐ Avbrytelse på grunn av forverrelse av pasientens tilstand ZXF00

☐ Beskyttende isolering ved immunsvikt WABA25

☐ Dråpesmitteisolering WABA15

☐ Kontaktsmitteisolering WABA10

☐ Luftsmitteisolering WABA20

☒ Prosedyre avbrutt av pasient ZXF30

Dokumenter undersøkelsen på vanlig måte.

- Legg til ansvarlige (O).
- Legg til ID-kontroll (D).
- Legg til legemidler dersom det er benyttet (P).
- Legge til demo der det er aktuelt (shift+D).
- Ev skanne henvisning/dokumenter (F9 Informasjonsvindu) (Alt+S).
- Ev legg til granskende lege (F9 Informasjonsvindu) (Alt+Y).

Dersom det er tatt bilder:

Klikk på «Journal» (J), velg «Kommentar til us». Skriv årsak til hvorfor undersøkelsen ble avbrutt. Signer selv eller endre signerende bruker.

Klikk på «Utført» og «Godkjenn».

Legg til en ny undersøkelse på samme henvisning.

+ Undersøkelse

Legg til henvisningsanmerking (N) og skriv beskjed til kontor om at us ble avbrutt og pasienten skal settes opp på ny time.

Klikk på «Merk som» til høyre i Undersøkelsesvinduet og velg «Flagg».

Sett på flagget «Time må endres».

Merk som ▾	Sendt eksternt
Akutt	Smitte
Ankomst	Time bør fremskyndes
Ikke bestill	Time kort varsel
Flagg ▸	Time må endres
	Tolk bestilt

Undersøkelsen vil komme opp på liste til kontor.

Dersom det ikke er tatt bilder:

Klikk på henvisningsanmerking (N) og velg «Avbrutt us», skriv årsak til hvorfor undersøkelsen ble avbrutt og om pasienten skal ha ny time eller ikke.

Signer selv eller endre signerende bruker.

Klikk på xAvbryt undersøkelsen

x Avbryt undersøkelsen

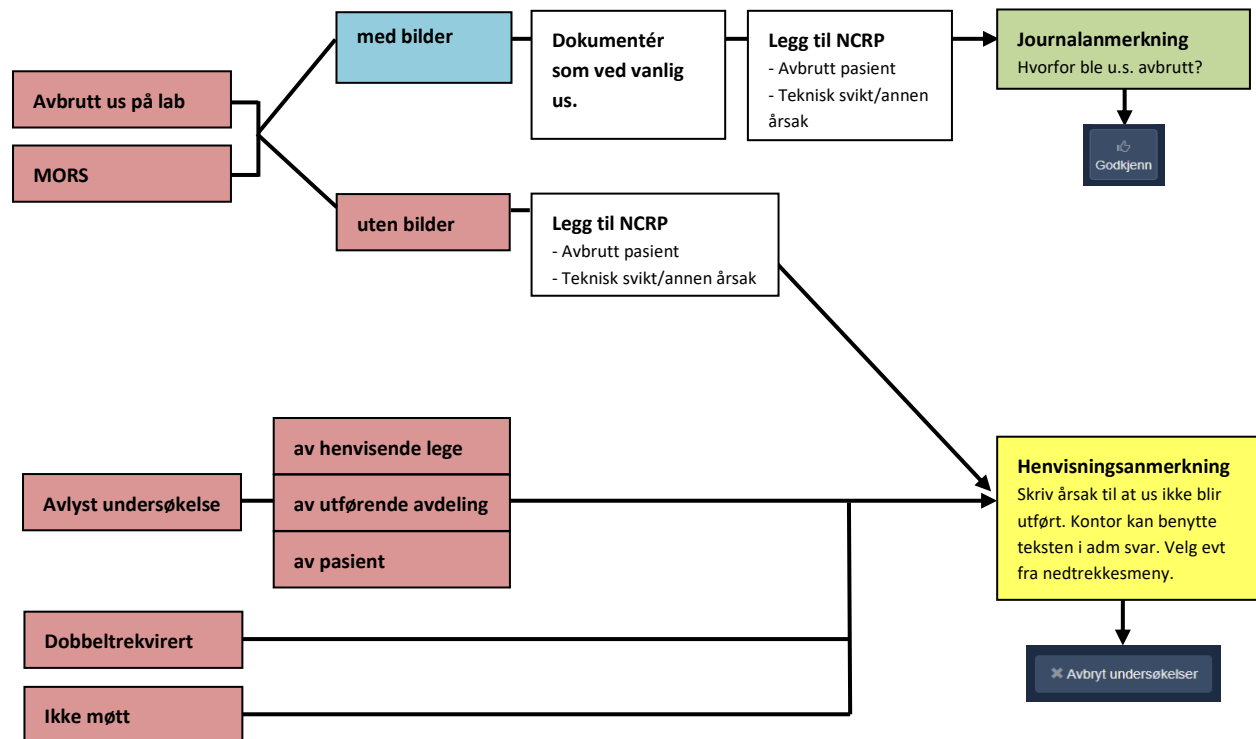
Velg «Avbrutt us» fra menyen. Innlogget bruker står default, ev velg annen bruker.

Klikk «Avbryt undersøkelsen» og undersøkelsen går til status «Godkjent».

Kontor finner us på adm avvik liste, lager adm svar og ev setter opp på ny time.

ADMINISTRATIVT AVVIK PÅ LAB

NÅR EN UNDERSØKELSE AVBRYTES, ELLER IKKE UTFØRES



REGISTRERE ALLERGISK REAKSJON PÅ KONTRAST ELLER LEGEMIDDEL

Kontrastmiddel- og legemiddelreaksjoner **skal dokumenteres i DIPS**, ansvaret for å gjøre dette ligger hos radiolog, Se dokument i ehåndbok (ID139153)

CAVE-informasjon som er registrert i DIPS vil vises i fanen «DIPS-Info» i Informasjonsvinduet (F9). Klikk på sirklene for å få opp informasjon.

Rød: Cave

Gul: Kritisk info



Granskende lege:

Marker aktuell undersøkelse i Informasjonsvinduet (F9) og velg «Granskende lege» -> «Angi granskende lege» (Alt+Y) for å angi hvilken lege som har vært involvert i hendelsen og skal registrere info i DIPS.

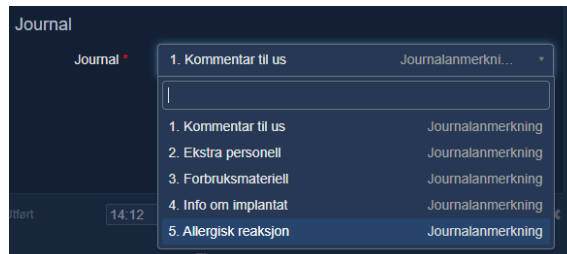
Angi granskende lege...

Journalanmerkning:

Gå i Undersøkelsesvinduet (F10).

Velg «Journal» (J) -> «5. Allergisk reaksjon» og fyll ut informasjon om hendelsen og hvordan det ble håndtert.

Signer selv eller velg annen bruker som skal signere.



Særskilt anmerkning:

Velg «Allergisk reaksjon» fra nedtrekksmeny. Denne følger på pasientnivå. Skriv dato for hendelsen, lokasjon og brukernavn i feltet «Viktig pasientinformasjon».

Dersom man må velge flere fra nedtrekksmenyen så velg «OBS!»



Svarrapport (radiolog/lege):

I svarrapporten skal det dokumenteres at pasienten har reagert, på hvilken måte og hvordan det er håndtert.

Radiolog skal også registrere CAVE i DIPS.

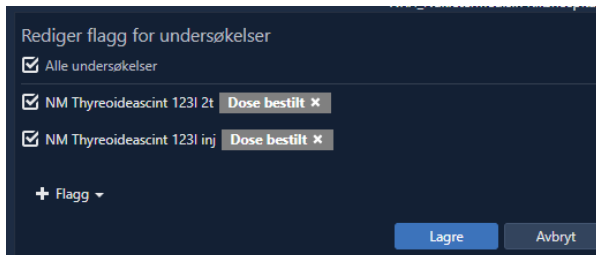
NUKLEÆRMEDISIN DOSEBESTILLING

Undersøkelser som krever dosebestilling havner på arbeidsliste NXX_Radiofarmaka bestilling når status Bestilt eller Innkalt. Listen viser bestilte timer 2mnd frem i tid.

Den som er ansvarlig for å bestille dose i IFE Portal setter også på flagget «Dose bestilt» og legger en tekst i henvisningsanmerkning at dose er bestilt.

! Viktig å legge flagget på alle delundersøkelser dersom det er en multibestilling.

! Viktig å dokumentere med henv.anmerkning at dose er bestilt til <dato>.



Legg til henvisningsanmerkning...

09.09.2022 13:44 - Hagve, Signe Elise
Dose bestilt til: 15.09.22

NM Thyroideascint 123I 2t
NM Thyroideascint 123I inj

FLAGG: DOSE MÅ HÅNTERES

Dette flagget benyttes når en undersøkelse med bestilt dose endres/avbestilles. Den som tar imot beskjed om endringen vil se i henvisningsanmerkningen at dose er bestilt og er ansvarlig for å markere dette slik at dosen håndteres best mulig (avbestilling av dosen i IFE Portal eller tildeling til annen pasient). Alle undersøkelser som er flagget med «Dose må håndteres» samles på listen **NXX Dose må håndteres**. Følgende alternativer for videre arbeidsflyt:

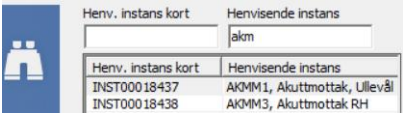
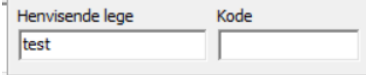
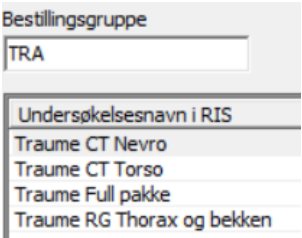
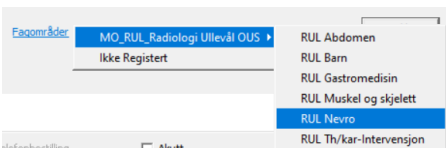
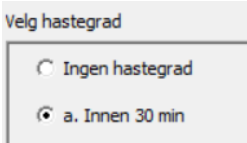
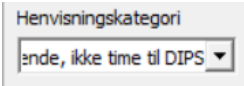
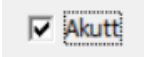
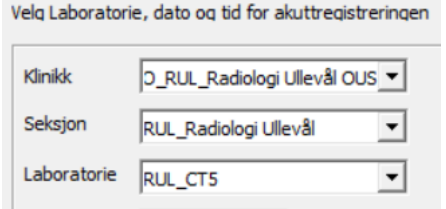
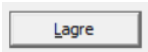
Alternativ 1 - Pasienten får ny time og opprinnelig dose tildeles ikke til annen pasient:

- Fjern flagget «Dose bestilt»
- Sett på flagget «Dose må håndteres».
- Pasienten får ny time og opprinnelig pasientbekreftelsen følger den nye timen. Da havner undersøkelsen automatisk på «NXX Radiofarmaka bestilling» og henvisningsanmerkningen for første dosebestilling makuleres.
- Dersom pasienten vil få en ny time senere i stedet må pasientbekreftelsen slettes.

Alternativ 2 – Pasienten får ny time og opprinnelig dose tildeles en annen pasient:

- Fjern flagget «Dose bestilt»
- Pasienten får ny time og opprinnelig pasientbekreftelsen følger den nye timen. Da havner undersøkelsen automatisk på «NXX Radiofarmaka bestilling» og henvisningsanmerkningen for første dosebestilling makuleres.
- Ring pasient som kan komme på den ombestilte timen (f.eks fra listen «Endre/fremskynde/Kort varsel» listen).
 - Avklar at hen kan komme på den aktuelle dagen. Sett opp den nye pasienten på time og dokumentér med en henvisningsanmerkning.
 - Huk av for pasientbekreftelse.
 - Sett på flagget «Dose bestilt» og henvisningsanmerkning «Dose bestilt til <us.dato>».

MANUELL REGISTRERING AV TRAUME ELLER TROMBOLYSE

Stå i RIS-vinduet og åpne «Henvisningsvinduet» (F3)	
Trykk på «Ny», eller Ctrl + N.	
Fyll inn fødselsnummer, trykk søk. <i>Trykk «Ja» på varsel om at «verdi ikke kan tolkes som fødselsnummer».</i>	
Trykk på Henvisende instans : Skriv inn «AKM» og velg «AKMM1». Trykk [Tab] på tastaturet, eller klikk på kikkerten med musen.	
Vindu for Henvisende lege kommer automatisk: Skriv inn etternavn eller HPR-nummer (kode) og trykk [Tab] på tastaturet.	
Vindu for valg av Undersøkelse kommer automatisk: Klikk på «Bestillingsgruppe» og skriv «TRA». Skriv «TRO» for trombolyse og velg «Trombolyse». Dobbeltklikk på aktuell gruppe så vil undersøkelsene legges til. Dobbeltklikk på en undersøkelse i nederste felt for «Valgte undersøkelser» for å fjerne.	
Klikk på Fagområder . Marker en eller flere undersøkelser og legg til riktig fagområde. Dette kan også gjøres i ettertid i Informasjonsvinduet (F9).	
Klikk på Hastegrad og marker alle undersøkelsene. Velg «Innen 30min».	
Velg Henvisningskategori «Inneliggende, ikke time til DIPS»	
Klikk på akutt -haken.	
Klikk på lagre -ikonet for å lagre henvisningen.	
Velg klinikk «RUL_Radiologi Ullevål OUS» Legg til lab: RUL_RG9 = Akuttstua RUL_UL9_AMB = Ultralyd akuttstua RUL_CT5 = CTAKU RUL_XA6 = INTIAKU	
Klikk lagre . Velg om du vil ankomstregistrere pasienten eller ikke. Klikk lagre for de resterende undersøkelsene til samme lab eller endre lab.	

ETTERARBEID VED TRAUME

HENVISNINGSVINDU I RIS (F3)

Endre henv lege:

Gå i henvisningsvindu i RIS (F3). Klikk på blyanten for å redigere henvisningen.

Klikk på «Henvisende lege». Søk opp navn/HPR nr og klikk [TAB] på tastaturet.



Henvisende lege	Kode
test	

UNDERSØKELSESVINDU (F10)

Dokumentasjon av us gjøres på vanlig måte

Se egen hurtigguide

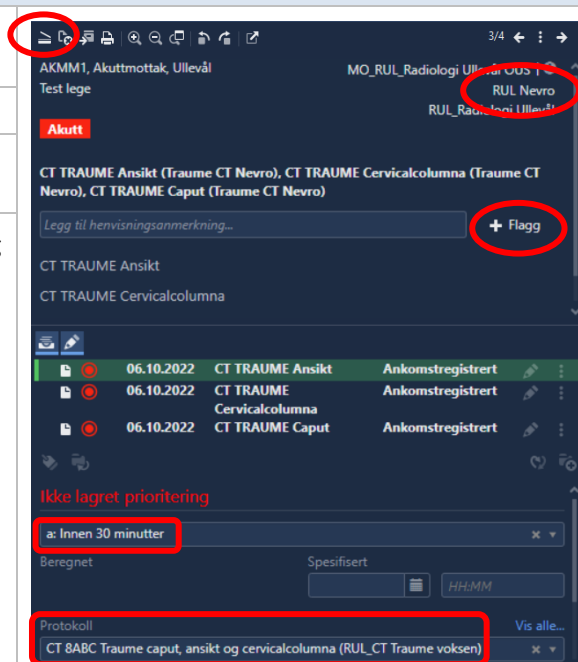
INFORMASJONSVINDU (F9)

Skann henvisning ved å klikke på skanne-ikon eller Alt+S

Legg til/endre **fagområde**

Sett på **flagg** dersom det er aktuelt. F.eks smitte, lang us.

Legg til aktuell protokoll: Merk alle undersøkelsene og legg inn priokode (grad av hast) og protokoll. Klikk «Signer».



Dersom barnetraume: Marker alle us i lab-listen og klikk Shift+D. Skriv «rul-b» og legg til «**RUL-B-Barnekir Dem**».

Andre demoer trengs ikke legges inn. Går automatisk eller meldes opp til demo av kliniker i etterkant.

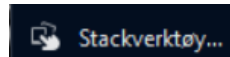
Demonstrasjoner

rul-b
RUL-B-Barnekir Dem

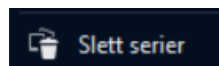
MATRISSEVINDU (F8)

Flytte bilder/serier: Marker undersøkelsen med bilder. Klikk på aktuelt bilde/serie(r) og drag-drop til aktuelle undersøkelseslinjer (kun mulig innad i samme pasient).

Dele opp serier: Benytt stackverktøy dersom man vil dele opp serier.



Slette bilder: høyreklikk på bildet/serien og velg «Slett serier»

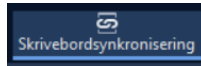


FLYTTE BILDER TIL ANNEN PASIENT ID

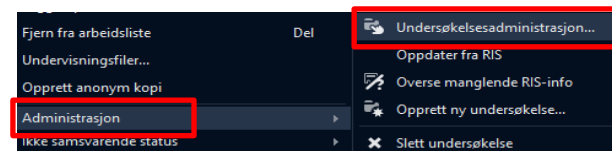
INFORMASJONSVINDU (F9)

Søk opp/finn aktuell pasient som bildene skal **FLYTTES FRA**. Klikk på aktuell undersøkelse i pasienthistorikken der bildene ligger som du ønsker å flytte.

Klikk på «Skribesynkronisering» for å skru av synk mellom RIS og PACS (blå understreking forsvinner).



Høyreklikk på undersøkelsen og velg «Administrasjon» -> «Undersøkelsesadministrasjon».



Velg «Flytt denne undersøkelsen til en annen pasient med annet fødselsnummer».

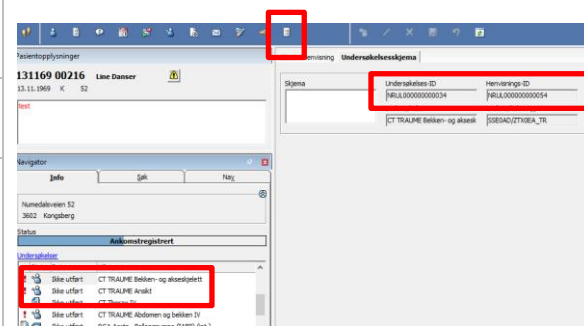
☒ Flytt denne undersøkelsen til en pasient med et annet fødselsnummer.

RIS (F6)

Søk opp den riktige pasienten som bildene skal **FLYTTES TIL**.

Velg den aktuelle undersøkelsen som bildene skal flyttes til.

Klikk på ikon «Undersøkesskjema» øverst på menylinjen slik at henvisningsID og undersøkelsesID blir synlig.



INFORMASJONSVINDU (F9)

Gå tilbake til «Undersøkelsesadministrasjon»-vinduet.

Kopier (Ctrl+C) henvisningsID og undersøkelsesID fra RIS til administrasjonsvinduet.

Klikk «Neste».
Sjekk at kilde og destinasjon er korrekt.
Klikk «Fullfør».

Bildene blir flyttet til korrekt pasient.

Undersøkelsesadministrasjon

Kopier undersøkelsens innhold

Legg inn undersøkelsesidentifikatorer for undersøkelsen du vil kopiere denne undersøkelsen til.

Kilde

Henvisnings-ID

NRRH000000000704 [Kopi](#)

Undersøkelses-ID

NRRH000000001180 [Kopi](#)

Destinasjon

Henvisnings-ID

NRRH000000000065

Undersøkelses-ID

NRRH000000000049

Klikk på «Skribesynkronisering» igjen for å skru på synk mellom RIS og PACS.

ETTERREGISTRERING AV HENVISNING VED NEDETID

MANUELL REGISTRERING AV HENVISNING I RIS

Registrer henvisning manuelt i «Henvisningsvinduet» (F3) i RIS.

Legg undersøkelsen på dagens dato og på aktuell lab som us ble utført på i Undersøkelsesvinduet (F10).

DOKUMENTERE UNDERSØKELSE

Undersøkelsesvindu (F10):

Dokumenter undersøkelsen på vanlig måte:

- Kontrollere klinikk og fagområde.
- Legg til/endre aktuelle undersøkelser.
- Kontrollere/endre NCRP.
- Legge til ansvarlige (O)
- Legge til ID-kontroll (D).
- Legge til legemidler (P).
- Legge til demo (kan bruke ikonet dersom man har kun 1 us) (shift+D)
- Ev legge til kommentar til undersøkelsen (J).
- Ev legge til viktig pasientinfo.

Informasjonsvindu (F9):

- Legge til demo (dersom det er flere us) (shift+D).
- Legge til granskende lege (Intervensjon og UL us) (Alt+Y).
- Skanne henvisning/dokumenter/papirsvar.

Klikk på «Start» og «Utført».

Endre «påbegynt tid» og «utført dato og tid» *bakover i tid* i undersøkelsesvindu (F10). Må gjøres **FØR** man godkjenner.

Påbegynt	16:32	10.10.2022
Utført	16:32	10.10.2022

Send bildene fra modalitet.

Klikk på «Skribesynkronisering» for å skru av synk.



Skribesynkronisering

Finn bildene i pasienthistorikken. Høyreklikk på bildelinjen og velg «Administrasjon» -> «Undersøkelsesadministrasjon».

Administrasjon


Undersøkelsesadministrasjon...

Hvis bildene har riktig pasientnavn og fødselsnummer kan man velge «Endre henvisningsnr....»
Hvis bildene har annet pasientnavn og fødselsnr kan man velge «Flytt denne undersøkelsen...»

☐ Flytt denne undersøkelsen t

☒ Endre henvisningsnummer

Gå i RIS og klikk på aktuell undersøkelse som bildene skal kobles til i pasient navigatoren. Klikk på ikonet «Undersøkesskjema».



Kopier ut henvisnings-ID og undersøkelses-ID og lim inn i undersøkelsesadministrasjonvinduet i PACS. Klikk «Neste», sjekk at koblingen stemmer og klikk «OK».

Undersøkelses-ID	Henvisnings-ID
NKRH000000005781	NKRH000000003084

Sjekk bildene i matrisevinduet og heng bilder der det er aktuelt. Husk «Systemlagre» alle endringer.

Klikk «Godkjenn» i undersøkelsesvinduet. Skru på «Skribesynkronisering» igjen.

Høyreklikk på undersøkelsen i pasienthistorikken i Informasjonsvinduet (F9) og velg «Egenskaper».

Egenskaper...

Endre dato og tid for når undersøkelsen ble utført.

Dato og tidspunkt

10.10.2022 16:32:00 

Bestilt dato og tidspunkt

10.10.2022 16:32:00 

RESERVASJON/SPERRING I TIMEBOK

RESERVASJON I TIMEBOK

Reservasjon i timebok kan overbookes og vises med blått stoppskilt. 

Sperring av time kan ikke bookes på og vises med rødt stoppskilt. 

Gå i RIS og klikk på ikonet «Timebok» fra verktøymenyen.

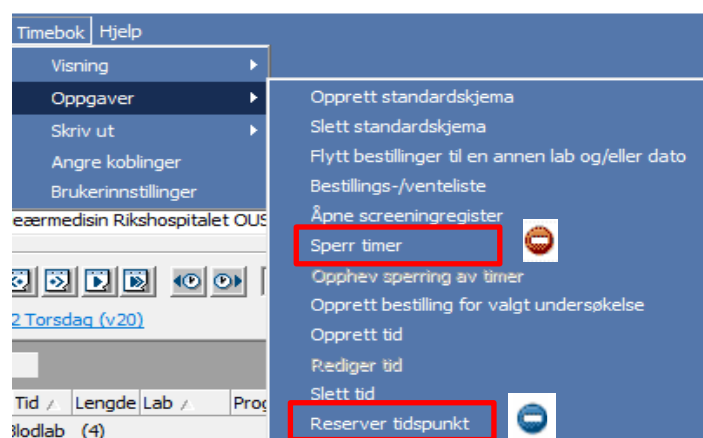


Velg klinikk og aktuell lab.

Klinikk	Laboratorie
MO_RUL_Radiologi Ullevål OUS	RUL_MR4

Velg tid for reservasjonen i. Merk aktuelt klokkeslett eller timeslått i Timeboken.

Klikk på «Timebok» -> «Oppgaver» -> Velg «Reserver tidspunkt» eller «Sperr timer».



Skriv inn klokkeslett eller varighet på hvor lenge reservasjonen skal vare.

Dersom man skal reservere tid utover tidsslått så må man gjøre en ny reservasjon i tilstøtende tidsslåt.

Reservere time

Dato	Lab	
13.10.2022 13:	RUL_MR4	
Starttid	Stopptid	Varighet
12:00	13:00	60
Kommentar		
Reservert for narkosepasient.		
Ok		Avbryt

Reservasjonen vises med blått eller rødt stoppskilt og en kommentar i Timeboken.

Type	Tid /	Lengde	Program	Lab	Kommentar
	09:00	135	MR Abdomen	RUL_MR4	
•	12:00	60	MR Angio	RUL_MR4	Reservert for narkosepasient
•	13:00	120	MR Abdomen	RUL_MR4	Reservert for narkosepasient
•	15:00	120	MR Abdomen	RUL_MR4	
•	18:30	165	MR Nevro	RUL_MR4	

ARKIVERING AV BILDER MED OG UTEN EHENVISNING

Gjelder kobling og lagring av tilsendte bilder hvor vi kun har fått følgeseddel og beskrivelser fra avsendersykehus, eller bilder som er henvist til demonstrasjon. Bildene skal arkiveres på denne måten selv om vi har fått henvisning til demonstrasjon, da demohenvisningen kun skal inneholde en eller flere linjer med prefiks REDEM.

INFORMASJONSVINDU (F9)

- Søk opp pasienten og se om bildene allerede er koblet før du fortsetter.
- Bilder som ikke er koblet i PACS har ikonet  foran seg.
- Det skjer ofte at bildene kobles i forbindelse med demonstrasjon. Du trenger da ikke foreta deg noe. Sjekk bare at beskrivelser er skannet inn, og makuler papirene.

HENVISNINGSVINDU (F3)

- Dersom du ikke har en e-henvisning for arkivering, klikk **Ny** for å opprette en ny henvisning.
- Velg henvisende instans **Import uten henvisning** og henvisende lege **aa, zzz import**. (Dersom du har mottatt en henvisning til arkivering, lar du instans og lege stå som utfylt.)
- Åpne vinduet **Valgte undersøkelser** og legg inn alle aktuelle undersøkelser ved å søke dem opp i feltet **Undersøkelsesnavn i RIS**. Når du har funnet riktig undersøkelse, dobbeltklikk på den eller tast **Mellomrom** for å legge den til. Gjenta til du har lagt til alle aktuelle undersøkelser, og klikk deretter **Velg** nederst i vinduet. Du kan også bare taste **Enter**.
- Det er ikke nødvendig å velge **Fagområde** når du arkiverer.
- Sett henvisningskategori **Arkivering**,
- Legg til hastegrad **TS arkivering** på alle undersøkelser du registrerer.
- Hak av for **Skal ikke best**.
- Åpne vinduet for henvisningsanmerkning ved å klikke på den blå lenken eller taste **Alt+8** og skriv inn hvor de aktuelle bildene er tilsendt fra. F. eks. «**Telerad fra Kristiansand**.» Dersom de er mottatt uten primærbeskrivelse, skal dette også nevnes i anmerkningen.
- Klikk **Legg til** for å legge til anmerkningen du har skrevet og lukke anmerkningsvinduet.

UNDERSØKELSESVINDU (F10)

- Velg aktuell undersøkelse fra listen ved å klikke på den.
OBST! Dersom det er flere undersøkelser fra forskjellige datoer som skal arkiveres, sjekk at haken **Alle** over undersøkelseslisten til venstre ikke er haket av, ellers vil alt du gjør gjelde alle undersøkelser, og de får dermed det samme tidspunktet og dato som den første. Dette kan likevel være gunstig dersom du faktisk har flere undersøkelser som er tatt samtidig, så du må vurdere dette ut fra hvert enkelt tilfelle.
- Klikk på knappene for **Start** og **Utført** eller tast **Alt+1** og **Alt+2**.
- Endre dato og klokkeslett i feltet **Utført** til når den aktuelle undersøkelsen er tatt.
- **Lagre** og gjenta for alle aktuelle undersøkelser.

INFORMASJONSVINDU (F9)

- På den aktive undersøkelsen i PACS, høyreklikk og velg **Opprett ny undersøkelse**.
- Velg undersøkelsen du skal flytte bilder fra. (Linjen med ikonet )
- Høyreklikk og velg **Undersøkelsesadministrasjon**.
- Bilder skal aldri kopieres. Velg **Flytt denne undersøkelsen ...** i vinduet som åpnes. Klikk **Neste**.
- Finn riktig undersøkelse ved å sammenligne **Henvisnings-ID** og **Undersøkelses-ID** med informasjonen som finnes i vinduet **Undersøkesskjema** i RIS. Du kan også kopiere og lime inn disse ID-ene.
- Klikk **Neste** og **Fullfør** for å starte flyttingen av bildene. Dette kan ta noen minutter.
- Gjenta for alle aktuelle undersøkelser.

UNDERSØKELSESVINDU (F10)

- Klikk på knappen **Godkjenn** eller tast **Alt+3** for å godkjenne. Det er mulig å godkjenne alle samtidig når haken **Alle** over undersøkelseslisten er på.

REGISTRERE HENVISNING TIL DEMONSTRASJON

Gjelder henvisninger til demonstrasjon eller vurdering og ev arkivering av tilhørende bilder.

INFORMASJONSVINDU (F9)

VERIFISERINGSLISTE

- Åpne den aktuelle verifiseringslisten og velg hvilken henvisning du skal jobbe med.
Henvisninger til demo har navnet **11 Demonstrasjon/tilsendte us.**

INFORMASJONSVINDU (F9)

Endre undersøkelseskoden, og legg ev. inn resterende aktuelle undersøkelser. Kodene du skal bruke avhenger av følgende:

- Ved første gangs demonstrasjon/vurdering opprettes en **DEM-linje** med navn som inneholder de undersøkelsene som skal demonstreres:
DEM {modalitet + område}, Vurdering tils. us.
Her kan du bruke samlekoder for å slippe mange DEM-linjer i de tilfellene det er flere undersøkelser innenfor samme område som skal demonstreres, også flere undersøkelser fra forskjellige datoer.
(Eks: **DEM MR Caput, Vurdering tils. us** eller **DEM CT Thorax/Abdomen/Bekken, Vurdering til. us**)
Du trenger kun flere DEM-linjer dersom det er flere ulike modaliteter, eller det ikke finnes en samlekode hvor du kan inkludere flere av undersøkelsene.
- Dersom bildene er våre egne eller har vært demonstrert fra før opprettes i stedet en **REDEM-linje** med navn på det radiolog-fagområdet som skal demonstrere bildene.
(Eks: **REDEM RH Abdomen** eller **REDEM UL Nevro**)

Dersom det ønskes demonstrasjon og de aktuelle bildene ikke er koblet, må dette gjøres på en egen manuelt opprettet henvisning senere. Bilder skal ikke kobles til demohenvisningen. Dersom de kun ønskes arkivert, kan du bruke e-henvisningen du har mottatt og følge flyten for arkivering.

RIS HENVISNINGSVINDU (F3)

- Se over henvisningen slik at riktig henvisende instans og lege er registrert. Hvis det står **Ukjent** i feltet for henvisende instans eller lege, kan du finne dette i henvisningsvinduet (**F7**) i DIPS inne på den aktuelle RAD-henvisningen. Du må åpne den aktuelle henvisningen for å se henvisende avdeling. Hvis du ikke får opp den aktuelle legen i RIS velger du **aa, venter på lege**.
- Legg til aktuelt **Fagområde** og **Hastegrad** på alle undersøkelser du registrerer.
- Åpne vinduet for **Henvisningsanmerkning** ved å klikke på den blå lenken eller taste **Alt+8** og skriv inn modalitet og dato for hvilke undersøkelser som skal demonstreres.
(Eksempel: «**DEM CT 03.02.11**» eller «**REDEM MR 01.02.22**»)
- Klikk **Legg til** for å legge til anmerkningen du har skrevet og lukke anmerkningvinduet.

UNDERSØKELSESVINDU (F10)

- Velg aktuell undersøkelse fra listen.
- Klikk på knappene for **Starttid** og **Stopptid** eller tast **Alt+1** og **Alt+2**.
- Datoen på **DEM-** og **REDEM-linjer** skal være den samme som demonstrasjonsdatoen. Det er mulig å sette dato frem i tid.
- Klikk på knappen **Godkjenn** eller tast **Alt+3** for å godkjenne undersøkelsene du har jobbet med. Det er mulig å godkjenne alle samtidig ved å sette på haken **Alle** over listen av undersøkelser før du godkjenner.

INFORMASJONSVINDU (F9)

- På aktuell **DEM-/REDEM-linje** i PACS, høyreklikk og velg **Opprett ny undersøkelse**. Dette setter arkivstatus til Original og gjør linjen søkbart i PACS.
- Skann inn aktuelle papirer ved å høyreklikke på riktig undersøkelse og **Skann dokumenter**.
- Legg **DEM-** eller **REDEM-linje** og de aktuelle undersøkelsene til riktig demonstrasjon ved å markere dem i vinduet **Pasienthistorikk**. Hold nede **Ctrl** for å markere flere linjer. Du må også legge tilhørende **DEM-linjer** til demonstrasjon sammen med de arkiverte når du jobber med **REDEM-linjer**, da det er her den opprinnelige radiologvurderingen ligger.
- Klikk ikonet **Til Demo** i verktøyraden øverst og velg riktig demo og dato. Ved flere undersøkelser, høyreklikk og velg «Demonstrasjon» -> «Legg til demo» eller tast shift+D

RIS HENVISNINGSVINDU (F3) /INFORMASJONSVINDU (F9)

- Skriv henvisningsanmerkning på alle arkiverte undersøkelser du har lagt til demonstrasjon. Anmerkningen skal vise til hvilken **DEM-linje** radiologens vurdering finnes.
Eksempel: «**Vurderes på DEM datert 15.02.22**»
Du trenger kun å gjøre denne jobben **første** gang undersøkelsen demonstreres, ikke ved senere regransking og redemonstrasjon.